APPROVED AUGUST 2026



GENERAL PATIENT CARE BOOK 1

LOS SANTOS EMS AGENCY
PREHOSPITAL CARE TREATMENT

1 DÉFINITIONS 3
1.1 Certifications médicales 3

2 PROCÉDURES INITIALES 4
2.1 Évaluation de la scène 4
2.2 Évaluation initiale — ABCDE 5
2.3 Paramètres vitaux de référence 5
2.4 Échelle AVPU (EMT) 7
2.5 Échelle de Glasgow (P) 8
2.6 Échelle de la douleur 8

3 INDICATIONS PARTICULIÈRES 9
3.1 Refus de prise en charge 10
3.2 Patients en détention 11
3.3 Détermination de la mort 12
3.4 Scènes de crimes et suicides suspectés 13
3.5 Contention nécessaire 14
3.6 Transport précoce (BLS) 16

4 PROCÉDURES PARTICULIÈRES 17
4.1 Port du gilet pare-balle 17
4.2 ePatient Care Report 18

5 INVENTAIRE MINIMUM DES UNITÉS BLS 19

PRÉFACE

Ces protocoles traitent des compétences minimales dont les EMTs de la Ville et du Comté de Los Santos devront faire preuve aux niveaux BLS et ALS.

Les EMTs, quel que soit leur niveau de formation, sont encouragés à contacter le contrôle médical lorsqu'ils estiment qu'un traitement supplémentaire est justifié au-delà des compétences communes et ordres généraux, ou en cas d'incertitude concernant le bon traitement d'un patient. Les BLS sont encouragés à faciliter l'intervention opportune et appropriée des ALS. Lors du transfert de soins d'un EMT à un autre, le transfert doit toujours se faire vers un EMT d'un niveau égal ou supérieur, sauf si l'état du patient et les complications raisonnablement prévisibles peuvent être pris en charge par un EMT de niveau inférieur dans le cadre de son champ d'activité et de ses compétences.

Ces procédures sont autorisées par l'Agence EMS de la Ville et du Comté de Los Santos.

Approuvé :  Date : 08/09/2026

Alan Williamson, MD

1 DÉFINITIONS

Ces protocoles traitent des compétences minimales dont les EMT[1] devront faire preuve aux niveaux BLS[2] et ALS[3]. Les EMTs BLS sont encouragés à faciliter l'intervention opportune et appropriée des ALS. Lorsqu'un EMT transfère un patient vers un autre EMT, il doit s'assurer que ce dernier soit au moins à un niveau de certification (voir plus bas) égal ou supérieur ; des exceptions sont accordées s'il est évident que le patient en cours de traitement peut être pris en charge par un EMT disposant d'une certification plus basse.

1.1 Certifications médicales

D'après les protocoles standardisés de l'EMS Agency[4], le Los Santos Fire Department reconnaît deux certifications médicales distinctes ;

L'**Emergency Medical Technician-Basic**, ou **EMT-B**, est un ambulancier disposant d'un niveau médical BLS ; il se limite aux procédures de son niveau et se concentre sur les premiers secours.
Il est simplement nommé "*EMT*".

L'**Emergency Medical Technician-Paramedic**, ou **EMT-P**, est un ambulancier disposant d'un niveau médical ALS ; il dispose d'une plus large panoplies de soins et peut intervenir sur des cas urgents critiques nécessitant une plus grande attention médicale.
Il est simplement nommé "*Paramedic*", mais reste un EMT.

[1]EMT ; Emergency Medical Technician, toute personne prodiguant des soins d'urgence.
[2]BLS ; Basic Life Support, désigne des soins de niveau basique.
[3]ALS ; Advanced Life Support, désigne des soins de niveau avancé.
[4]EMS Agency ; organisme en charge de la gestion des protocoles médicaux dans le comté de Los Santos.

2 PROCÉDURES INITIALES

2.1 Évaluation de la scène

TABLEAU 2.1-A ORDRE DE PROCÉDURES AVANT TRAITEMENT (HAUT-BAS ET GAUCHE-DROITE)

SCHÉMA GÉNÉRAL	CONSCIENCE/AVPU AIRWAY BREATHING CIRCULATION Pouls Remplissage capillaire Contrôle d'hémorragie	INSPECTION DE LA PEAU Couleur Température Moiteur PLAINTE PRINCIPALE Impressions objectives[1] Impressions subjectives[2] [1]Ce que le pompier voit. [2]Ce que le patient dit.
SCÈNE Sécurité de l'environnement Sécurité du personnel (EPI) Sécurité du patient Mécanisme de la blessure Nombre de patients		
IMPRESSION GÉNÉRALE Ce que le pompier voit.		

TABLEAU 2.1-B RÉFLEXES PRIMORDIAUX SUR INTERVENTION

1 — ÉVALUER LA SÉCURITÉ DE LA SCÈNE

- Évaluer les risques pour le personnel intervenant, le patient et les passants.
- Éloigner le patient des dangers avant de commencer les soins médicaux.
- Déterminer le nombre de patients.
- Déterminer la blessure ou la source potentielle de la maladie.
- Demander des ressources supplémentaires si nécessaire.
- Évaluer le rapport soins sur place/transport immédiat et décider.
- Envisager la déclaration d'un MCI (Mass Casualty Incident).

2 — UTILISER LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE APPROPRIÉS

- Tenir compte des dangers suspectés ou confirmés sur les lieux
- Tenir compte des maladies contagieuses suspectées ou confirmées.
- S'équiper en conséquence (casque, masque, gants, lunettes, ...).
- Porter un gilet haute visibilité ou une veste réfléchissante si nécessaire.

3 — ENVISAGER UNE IMMOBILISATION IMMÉDIATE DU PATIENT SI NÉCESSAIRE

2.2 Évaluation initiale — ABCDE

A — AIRWAYS

Vérifier les bruits des voies aériennes, la position de la tête, la présence de corps étrangers (ou de sécrétions/liquides) ou la présence d'oedème (gonflement anormal des tissus). Si le patient parle, considérer les voies aériennes comme libres, sinon :

Incliner la tête en arrière et relever le menton, aspirer les sécrétions et liquides, utiliser une canule de Guedel ou retirer le corps étranger au moyen d'une pince de Magill.

B — BREATHING

Écouter la respiration et regarder la respiration thoraco-abdominale, vérifier la fréquence respiratoire (en cycles par minute), vérifier la présence de cyanose (peau bleutée) ou de déviation de la trachée, écouter les bruits de la respiration, notamment : stridor (bruit aigu) et wheezing (sifflements). Vérifier la saturation en oxygène (SpO2).

Selon les besoins, fournir un supplément d'oxygène pour atteindre une SpO2 à 94-98% et/ou ventiler.

C — CIRCULATION

Contrôler la fréquence cardiaque et la tension artérielle et évaluer la perfusion périphérique (temps de remplissage capillaire et coloration de la peau) et vérifier la présence d'une hémorragie.

Traiter toute hémorragie en priorité, évaluer la vitesse et la qualité des pouls carotidien et/ou radial. Se référer aux protocoles concernés tel que nécessaire.

D — DISABILITY

Procéder à un examen neurologique de base (orientation temporo-spatiale), vérifier la glycémie. Vérifier la taille, la réactivité et la symétrie des pupilles. Si nécessaire, réaliser un examen toxicologique.

Évaluer le patient au moyen de l'échelle de Glasgow/AVPU, évaluer la motricité et la fonction sensorielle de tous les membres, vérifier systématiquement la glycémie si le patient présente un état mental altéré.

E — EXPOSURE

Effectuer un examen de la tête aux pieds (recherche de lésions, anomalies ou traces de toxicomanie), vérifier les antécédents médicaux du patient tel que possible. Vérifier la température ou des signes d'infection.

Se référer aux protocoles concernés tel que nécessaire.

2.3 Paramètres vitaux de référence

TABLEAU 2.3-A PARAMÈTRES VITAUX DE RÉFÉRENCE

FC (ÉVEILLÉ, BPM) 60-100	**FC (ENDORMI, BPM)** 50-90
FR (CYCLE/MIN) 12-20	**GAJ (g/L)** 0.70-1.10
Gly (g/L) < 1.40	**TA (mmHg)** 90/50 à 140/90

FC ; fréquence cardiaque.
FR ; fréquence respiratoire.
GAJ ; glycémie à jeun.
Gly ; glycémie.
TA ; tension artérielle.

2.4 Échelle AVPU (EMT)

TABLEAU 2.4-A ALERT - VERBAL - PAIN - UNRESPONSIVE (AVPU)

A — ALERT
Les yeux sont ouverts de façon spontanée.
Le patient semble conscient de son environnement.
Bonne réponse aux instructions, capable de suivre un objet avec ses yeux.

V — VERBAL
Les yeux ne s'ouvrent pas de façon spontanée, mais s'ouvrent sur instruction.
En capacité de répondre de façon compréhensible et cohérente.

P — PAIN
Ne répond pas verbalement, mais réagit/répond à la douleur.

U — UNRESPONSIVE
Le patient ne répond à aucun stimuli, pleine inconscience.

2.5 Échelle de Glasgow (P)

TABLEAU 2.5-A ÉCHELLE DE GLASGOW

MESURE	DESCRIPTION	SCORE
Ouverture des yeux (4)	Spontanée	4
	À la demande	3
	À la douleur	2
	Aucune	1
Réponse moteur (6)	Obéit aux commandes	6
	Localise la douleur	5
	Retrait à la douleur	4
	Flexion stéréotypée à la douleur	3
	Extension stéréotypée à la douleur	2
	Aucun	1
Réponse verbale (5)	Orientée	5
	Confuse	4
	Paroles inappropriées	3
	Soins incompréhensibles	2
	Aucune	1
	TOTAL	

2.6 Échelle de la douleur

TABLEAU 2.6-A DIFFÉRENTS NIVEAUX DE DOULEUR

1 — DOUCE
Sensation à peine perceptible, légèrement gênante.

2 — MINEURE
Gênante, montées sporadiques, supportable.

3 — INCONFORTABLE
Perceptible et désagréable.

4 — MODÉRÉE
Dérangeante en-dehors d'une activité.

5 — ENNUYANTE
Modérément forte, mais ignorable par moment.

6 — PÉNIBLE
Modérément forte, impact la concentration.

7 — SÉVÈRE
Douleur dominant les sens.

8 — INTENSE
Gêne la parole, perte d'autonomie.

9 — ATROCE
Conversation impossible, position couchée nécessaire.

10 — INIMAGINABLE
Douleur rare entraînant des malaises ou nausées.

3 INDICATIONS PARTICULIÈRES

3.1 Refus de prise en charge

CONTRE INDICATION
Une personne souffrant d'un handicap, étant dans une situation claire de détresse, ou disposant d'un état mental et/ou de conscience ne pouvant pas prétendre à des décisions éclairées n'est pas considérée comme étant en capacité de décider en son propre nom sa prise en charge.

De la même manière, une personne venant de tenter de se suicider, évoquant des pensées suicidaires, ou étant décrite par ses proches comme une personne suicidaire n'est pas considéré comme étant capable de décider de sa propre prise en charge.

Dans ces cas-là, l'EMT décide, ou non, du transport/de la prise en charge du patient.

TABLEAU 3.1-A ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À LA FICHE DE REFUS

- Constantes vitales du patient.
- Glycémie.
- Les plans du patient post-refus.[1]
- Raison du refus.
- Consommation de drogues/alcool.
- Âge du patient.
- Les personnes aux côtés du patient.[2]
- Liste des traitements effectués.

[1] Ce que le patient compte faire une fois libéré.
[2] Les personnes qui seront avec le patient une fois libéré.

IMPORTANT. Les EMTs en charge du patient refusant une prise en charge doivent l'avertir des risques que cela pourrait représenter pour sa santé, et confirmer que ces risques-là ont été compris par la personne. Le patient doit signer la fiche de refus.

3.2 Patients en détention

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les intervenants doivent réaliser une évaluation initiale et ciblée complète, incluant :

- Les constantes vitales,
- Les signes négatifs pertinents,
- Un compte rendu précisant le motif principal et/ou la raison de l'appel au 9-1-1.

Il est rappelé que l'évaluation chez ces patients peut être peu fiable, en raison de :

- Une possible consommation de substances illicites,
- Un accès limité à leurs traitements habituels,
- Ou de traumatismes sans signes évidents.

TRANSPORT

Le matériel de contention (menottes, attaches plastiques, ou entraves type "hobble") mis en place par les forces de l'ordre doit respecter les règles suivantes :

- Doit laisser un jeu suffisant pour permettre une ventilation efficace.
- Nécessite la présence continue d'un agent (dans l'ambulance).
- Ne doit pas compromettre les fonctions respiratoires ou circulatoires
- Ne doit entraîner aucune atteinte vasculaire, neurologique ou respiratoire.

Les membres immobilisés doivent être surveillés pour :

- La qualité du pouls,
- Le remplissage capillaire,
- La couleur de leur peau et la température,
- La fonction nerveuse et motrice.

Les dispositifs de contention peuvent être fixés au châssis du brancard, mais pas aux barrières latérales mobiles.

3.3 Détermination de la mort

CONDITIONS

Un patient est considéré comme décédé lorsque l'absence de respiration, d'activité cardiaque et de réflexes neurologiques s'additionnent à au moins l'un des cas présentés dans le tableau 3.3-A.

TABLEAU 3.3-A ÉLÉMENTS ADDITIONNELS À LA DÉTERMINATION DE LA MORT

Décapitation.	Écrasement massif.
Incinération.	Décomposition.
Désincarcération supérieure à 15 minutes sans tentative de réanimation effectuée.	Traumatisme pénétrant/contondant avec éviscération du cœur, du cerveau ou des poumons.
Arrêt cardio-respiratoire lors d'un incident impliquant plusieurs victimes sans ressources appropriées.	Patient noyé immergé sous l'eau pendant au moins une (1) heure de temps.
Rigidité cadavérique.	Après trois (3) tentatives de RCP.

PROCÉDURES SUIVANT LA DÉTERMINATION DE LA MORT

Tous les traitements initiés pendant la tentative de réanimation doivent rester en place, cela implique notamment : les cathéters, tubulures, électrodes, pansements, ...

Le défunt ne doit pas être déplacé sans l'autorisation explicite d'un membre du Département de Médecine Légale (coroners).

- NOTE : Il peut être nécessaire de déplacer, malgré tout, le défunt pour des raisons de sécurité. Dans ce cas-là, les EMTs présents sur place doivent s'assurer de le déplacer vers la zone la plus accessible qu'il soit, ou à défaut, de le transporter vers un centre adapté.

3.4 Scènes de crimes et suicides suspectés

TABLEAU 3.4-A CONDITIONS LORS D'UNE SCÈNE DE CRIME ET/OU D'UN SUICIDE SUSPECT

- La responsabilité de la gestion de la scène revient au personnel disposant des qualifications médicales les plus élevées.
- L'autorité de la gestion de la scène revient, si possible, aux forces de l'ordre présentes. Cela signifie également que les pompiers sur place doivent demander une assistance à ces derniers pour assurer la sécurité de l'intervention.
- Si les forces de l'ordre ne sont pas présentes, il est nécessaire de les contacter et d'assurer la sécurité de l'intervention jusqu'à leur arrivée.

3.5 Contention nécessaire

PRINCIPES

L'application de moyens de contention est une procédure risquée en raison de la possibilité de blessures, à la fois pour le patient et pour le personnel. De ce fait, la contention doit être réservée à des situations au cours desquelles le patient est violet ou présente un comportement dangereux pour les autres et pour lui-même. Ces principes doivent être suivis pour toute mise en place de moyens de contention :

- L'usage de la contention ne doit intervenir que lorsque toutes les mesures moins restrictives, comme la désescalade verbale, ont échoué.

- Le personnel intervenant doit tenir compte qu'un comportement agressif peut être le symptôme de conditions médicales, telles qu'un traumatisme crânien, une intoxication à l'alcool ou à d'autres substances, un trouble métabolique, un stress émotionnel ou des troubles comportementaux et psychiatriques.

- La sécurisation de la scène est coordonnée par les forces de l'ordre, le cas échéant.

- La responsabilité de la gestion des soins du patient incombe à la plus haute autorité médicale sur place.

    - La modalité de contention préférée doit être coordonnée avec les forces de l'ordre, le cas échéant.

    - La méthode de contention utilisée doit permettre une surveillance adéquate des signes vitaux et ne doit pas restreindre la capacité à assurer les voies respiratoires du patient ni compromettre son état neurologique ou vasculaire.

Cette politique n'a pas pour but de nier la nécessité pour le personnel des forces de l'ordre d'utiliser un équipement de contention approprié. Des indications supplémentaires sont inscrites dans le tableau 3.5-A.

TABLEAU 3.5-A INDICATIONS RELATIVES AUX MOYENS DE CONTENTION

Les dispositifs de contention appliqués par le personnel intervenant doivent être :

- soit des dispositifs de contention rigides rembourrés,
- soit des dispositifs de contention souples (c'est-à-dire des gilets de contention, des bandes Velcro ou des ceintures de contention).

Les deux méthodes doivent, dans toutes les situations, ne pas nécessiter de clé et permettre une ouverture rapide.

Les dispositifs de contention doivent être appliqués sous la forme de poignets et de chevilles rembourrés à quatre points ou de poignets et de ceintures rembourrés à deux points.

Les méthodes de contention suivantes NE DOIVENT PAS être utilisées par le personnel intervenant (hors forces de l'ordre) :

- Attaches en plastique dur ou tout dispositif de contention nécessitant une clé pour être retiré,
- Immobilisation des mains et des pieds d'un patient derrière son dos.
- Immobilisation des patients couchés sur le ventre,
- Placement d'un dispositif (par exemple, une planche dorsale) sur un patient couché sur un brancard ; méthode dite du « sandwich »,
- Application de matériaux d'une manière qui pourrait entraîner une atteinte vasculaire, neurologique ou respiratoire (par exemple, restriction des membres, du cou ou de la poitrine à l'aide d'un équipement inadapté).

- Dans certaines situations, les forces de l'ordre peuvent être amenées à utiliser des moyens de contention qui ne sont pas adaptés à une prise en charge médicale, et/ou non approuvées. Dans ces conditions, les patients nécessitant une prise en charge médicale et/ou un transport doivent être libérés par les forces de l'ordre, au profit d'une contention approuvée par le personnel médical intervenant.

Les dispositifs de contention appliqués par les forces de l'ordre nécessitent la présence continue d'un agent pour assurer la sécurité du patient et la sécurité de la scène.

- L'agent doit accompagner le patient dans l'ambulance,
- Dans un cas inhabituel où cela n'est pas possible, l'agent doit suivre l'ambulance,
- Si le patient est menotté par l'agent, il faut envisager de passer aux moyens de contention les moins restrictifs possibles, sans danger pour le patient et les intervenants, y compris le transfert vers les moyens de contention du personnel médical.

3.6 Transport précoce (BLS)

PRINCIPES

Dans certains cas, les intervenants BLS en charge d'un patient peuvent se retrouver face à une urgence imminente qui ne pourrait attendre l'arrivée d'une équipe ALS. Ces conditions sont précisées dans le tableau 3.6-A, et sont complétées par ces circonstances :

- Si le temps de trajet entre la scène d'intervention et un établissement hospitalier adapté est plus rapide que le temps estimé d'arrivée d'une unité ALS.
    - Transporter et considérer un point de rendez-vous pour le transfert du patient avec ladite unité ALS.
- Si le temps de transport estimé vers un établissement hospitalier adapté est supérieur à 10 minutes et qu'aucune unité ALS n'est disponible immédiatement.
    - Transporter.

TABLEAU 3.6-A ÉLÉMENTS POUVANT NÉCESSITER UN TRANSPORT PRÉCOCE

Détresse/arrêt respiratoire.	Obstruction des voies aériennes.
Dégradation neurologique significative depuis l'évaluation initiale.	Brûlures graves (deuxième ou troisième degré).
Accouchement imminent.	Hémorragie non maîtrisée.
Thorax/abdomen ouvert.	Polytraumatisme.
TC avec PCI.	Pneumothorax.

4 PROCÉDURES PARTICULIÈRES

4.1 Port du gilet pare-balle

CONDITIONS

Le port du gilet pare-balle est obligatoire dans toutes les situations décrites dans le tableau 4.1-A.

Le gilet doit être porté, si possible, sous une Brush Jacket, une veste ignifugée de lutte contre les flammes, ou tout autre haut pouvant, de manière pratique et fonctionnelle, cacher ce dernier sur une intervention.

TABLEAU 4.1-A SITUATIONS REQUÉRANT LE PORT DU GILET PARE-BALLE

- Agression avec une arme à feu.
- Fusillade.
- Alerte tactique.
- Incident impliquant un sniper.
- Violence domestique/dispute familiale.
- Agression avec arme contondante.
- Incident dans une zone à risque.
- Autres crimes violents.

Les pompiers sont autorisés à porter un gilet pare-balle dans n'importe quelle autre situation au cours de laquelle ils estiment que le port du gilet est nécessaire.

La carte des zones à risques est maintenue, mise à jour et publiée toutes les deux semaines. Son affichage en caserne est obligatoire.

4.2 ePatient Care Report

L'ePCR (pour Electronic Patient Care Report) est un dispositif permettant de compiler et transférer des informations médicales importantes aux autres organismes médicaux du comté de Los Santos ; notamment les hôpitaux pour une prise en charge plus fluide du patient à son arrivée. Ces rapports peuvent également être utilisés pour faciliter la compréhension des problématiques d'un même patient au cours de plusieurs interventions distinctes, notamment en guise d'historique médical.

L'unité opérant le transport du patient est chargée de la rédaction de l'ePCR, et est responsable de l'exactitude des informations renseignées.

TABLEAU 4.2-A INFORMATIONS MINIMALES REQUISES POUR LA RÉDACTION DE L'EPCR

- [redacted] Nom du patient.
- [redacted] Adresse du patient.
- [redacted] Numéro de téléphone du patient.
- [redacted] Date de naissance.
- [redacted] Plainte principale.
- [redacted] Observations pertinentes.
- [redacted] Signes vitaux.
- [redacted] Traitement(s) suivi(s) par le patient.
- [redacted] Allergies connues.
- [redacted] Médicaments administrés.
- [redacted] Procédures et manœuvres réalisées.
- [redacted] Personnel intervenant.

5 INVENTAIRE MINIMUM DES UNITÉS BLS

INVENTAIRE MINIMUM	QUANTITÉS
Ruban adhésif, rouleaux de 3, 5 et 8 centimètres	2 de chaque
Restrictions pour les poignets et les chevilles	1 set
Bandages et compresses, ou équivalence	26
BAVU	6
Masques simples et sacs O2	2
Ciseaux traumatiques	1
Tensiomètres	4
Colliers cervicaux	6
Dextrose - gel de glucose	15gms
Pansements hémostatiques	2
Équipements obstétricales	1 kit
Intubation - Nasotrachéale	6
Canules de Guedel	2
Équipement de Protection Individuelle (EPI) - gants, lunettes, ...	2 de chaque
Thermomètre	1
INVENTAIRE MINIMUM	**QUANTITÉS**
Tourniquets	2
Planches dorsales	3
Monte-escalier	1